

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, HYGIENE ET PREVENTIONS
PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TRYPANOSOMIASE
HUMAINE AFRICAINE (PNLTHA)



RAPPORT ANNUEL 2023

N° 1 Croisement Blvd. Triomphale, Av. de Libération – Kasa-Vubu

Email: directeurpnltha@gmail.com

B.P. 7782 KINSHASA I

PNLTHA, Février 2024

Table des matières

Liste des abréviations	iii
Remerciements.....	1
Résumé.....	2
1. Introduction.....	3
2. Organisation de la lutte contre la THA en RDC	6
2.1. Textes juridiques de création et historique du PNLTHA	6
2.2. Politique Nationale de lutte contre la THA en RDC	6
2.3. Structures et organisation.....	7
2.3.1. Niveau central	7
2.3.2. Niveau intermédiaire.....	8
2.3.3. Niveau périphérique ou opérationnel.....	9
2.4. Ressources humaines, matérielles et financières.....	10
2.4.1. Ressources humaines	10
2.4.2. Ressources matérielles, intrants de dépistage/diagnostic et trypanocides	11
2.4.3. Ressources financières	16
3. Détection précoce et traitement des cas.....	17
3.1. Villages programmés en dépistage actif avec les UM et MUM.....	17
3.2. Dépistage et diagnostic de la THA.....	20
3.3. Traitement des malades	277
3.4. Tendance évolutive des cas de THA ces dernières années	299
3.4.1. Tendance en RDC.....	299
3.4.2. Tendances dans les provinces endémiques	300
4. Contrôle du vecteur	344
4.1. Approche verticale	344
4.2. Approche communautaire (horizontale)	366
5. Activités d'appui	388
5.1. Outils TrypElim de collecte des données	388
5.2. Formation des prestataires	399
5.3. Recherche.....	400
5.4. Suivi des activités.....	411
6. Conclusion	444
7. Références.....	455

Liste des abréviations

BCT	: Bureau Central de la Trypanosomiase
CATT	: Card Agglutination Test for Trypanosomiasis
CDTC	: Centre de Diagnostic, Traitement et Contrôle de la THA
CPLTHA	: Coordination Provinciale de Lutte contre la THA
CS	: Centre de Santé
CSR	: Centre de Santé de Référence
CTB	: Coopération Technique Belge
CTC	: Centrifugation en Tubes Capillaires ou test de Woo
DA	: Dépistage Actif
DGD	: Direction Générale au Développement du Royaume de Belgique
DNDi	: Drugs for Neglected Diseases initiative
DP	: Dépistage Actif
ECP	: Equipe Cadre provinciale (au niveau de la Division Provinciale de la Santé)
ECZ	: Equipe Cadre de Zone de Santé
EPPI	: Eau de Préparation Pour Injection
FBR	: Financement Basé sur les Résultats
FIND	: Foundation for Innovative New Diagnostics
FOSA	: Formation Sanitaire
GE	: Goutte Epaisse
HGR	: Hôpital Général de Référence
ICAT	: International Course on African Trypanosomiasis
IMT	: Institut de Médecine Tropicale
LAMP	: Loop-mediated isothermal amplification
LAV	: Lutte Anti-Vectorielle
mAECT	: mini Anion Exchange Centrifugation Technique (Technique de mini colonne)
MCZ	: Médecin Chef de Zone de Santé
MSF	: Médecins Sans Frontières
MUM	: Mini-Unité Mobile

NC	: Nouveau Cas
OMS	: Organisation Mondiale de la Santé
ONG	: Organisation Non Gouvernementale
PATTEC	: Pan African Tsetse and Trypanosomiasis Eradication Campaign
PG	: Ponction Ganglionnaire
PL	: Ponction Lombaire
PNLTHA	: Programme National de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine
PTE	: Population Totale Examinée (Dépistée)
PTR	: Population Totale Recensée
RDC	: République Démocratique du Congo
SF	: Sang Frais
T.I	: Taux d'Infection
TDR	: Test de Diagnostic Rapide
THA	: Trypanosomiase Humaine Africaine
UM	: Unité Mobile
VPN	: Valeur Prédictive Négative
VPP	: Valeur Prédictive Positive
ZS	: Zone de Santé
ZSE	: Zone de Santé Endémique

Remerciements

Le résultat de cette lutte contre la THA rapporté dans ce document est l'œuvre de toutes les parties prenantes impliquées dans la lutte contre la THA en RDC :

- Les communautés dans les zones endémiques pour leur participation au dépistage et à l'adhésion au traitement,
- Les prestataires en général, les unités mobiles et mini-unités mobiles en particulier pour leurs itinérances de 20 jours chaque mois pendant 10 à 12 mois au cours de l'année, loin de leurs familles, dans des villages endémiques pour examiner les populations à risque de la THA,
- Les autorités sanitaires et politico administratives à tous les niveaux pour leurs accompagnements,
- Les partenaires d'appui techniques et financiers pour leurs soutiens,

A vous tous qui contribuez à cet objectif ambitieux de l'élimination de la THA en RDC, nous exprimons notre profonde gratitude.

Pour la direction du PNLTHA - RDC

Le Médecin Directeur

Eric MWAMBA MIAKA

Résumé

Le programme national de lutte contre la THA en RDC est un programme spécialisé du Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention. Il est structuré à trois niveaux de la pyramide sanitaire en RDC. Une coordination nationale qui est essentiellement normative et stratégique, 10 coordinations provinciales qui organisent l'appui techniques et logistiques aux structures périphériques (UM, MUM HGR et CS) qui exécutent le dépistage/diagnostic et traitement de la THA. L'objectif actuel de la lutte est d'éliminer la THA comme problème majeur de santé publique en RDC et ensuite d'arrêter sa transmission d'ici 2030. En 2023, le programme national a examiné un total 2.236.845 personnes dont 90 % (n= 2 015 832) en dépistage actif.

394 nouveaux cas ont été diagnostiqués dont 52 % en dépistage actif. 94 % de cas sont de cas parasitologiques et 6 % de cas sérologiques (trypanolyse positive). Les cas sérologiques ont été diagnostiqués en dépistage passif (échantillons envoyés à l'INRB). La participation communautaire au dépistage actif est de 85 % au niveau pays avec des faibles taux dans certaines coordinations provinciales comme l'Equateur sud (65%), Kinshasa (66%) et Sankuru (69 %).

Le taux d'infection en dépistage actif est de 1 pour 10 000 personnes au niveau pays. Ce taux est élevé dans certaines coordinations provinciales comme le Bandundu sud (2,3 %) et le Kasai occidental (3,3%). 18% (n=75, N=394) nouveaux cas diagnostiqués étaient encore au stade précoce de la maladie ce qui traduirait une transmission récente et donc un foyer où la transmission est active. C'est principalement les coordinations provinciales de Tshopo et du Kasai occidental qui ont notifié un nombre élevé des nouveaux cas au premier stade de la maladie. Actuellement le contrôle du vecteur se fait uniquement dans les coordinations provinciales du Bandundu nord et sud, nous pensons qu'il serait nécessaire d'élargir le contrôle de vecteur dans les autres provinces endémiques dont la transmission est encore active comme la Tshopo et le Kasai occidental. Dans d'autres coordinations provinciales comme celle de L'Equateur sud et du Kongo central, le nombre des cas ont sensiblement diminué. Ces coordinations provinciales avec la rareté de cas ont besoin d'une bonne surveillance passive et de commencer à réfléchir sur la documentation de l'élimination de la THA dans cette partie de la RDC.

1. Introduction

La Trypanosomiase Humaine Africaine (THA) appelée également « maladie du sommeil » est une Maladie Tropicale Négligée (MTN) qui touche principalement les populations pauvres vivant dans les zones rurales en Afrique subsaharienne qui correspondent aux zones de distribution de la mouche tsétsé. Cette maladie est une parasitose à transmission essentiellement vectorielle provoquée par un protozoaire du genre *Trypanosoma*. Deux sous-espèces sont pathogènes pour l'homme. *T. brucei gambiense* entraîne une forme chronique de la maladie qui est endémique en Afrique centrale et de l'Ouest. Cette forme qui représente environ 95% des cas est celle qu'on rencontre en République Démocratique du Congo (RDC). *T. brucei rhodesiense* provoque une forme aiguë qui est endémique en Afrique de l'Est et en Afrique australe (représente qu'environ 5% de cas).

La THA est focalisée dans les mêmes foyers., En RDC ces foyers sont ouverts et traversent de fois plusieurs zones de santé endémiques. Neuf de onze provinces (ancienne subdivision) sont endémique à la THA. La THA est endémique dans presque toutes les provinces, sauf le nord et le sud Kivu (ancienne subdivision) où les conditions climatiques ne sont pas favorables à la survie la mouche tsétsé qui est l'agent vecteur.

Selon l'OMS (2018 et 2022) le nombre de nouveaux cas notifié à l'OMS a évolué de 25 841 cas en 2000 à 565 cas en 2020. Presque 70 % (n=395 ; N=565) de cas notifié à l'OMS en 2020 proviennent de la RDC. L'évolution de cas en RDC influence fortement la courbe épidémiologique de l'Afrique (tous les pays endémiques) comme l'on peut le voir sur la figure 1.

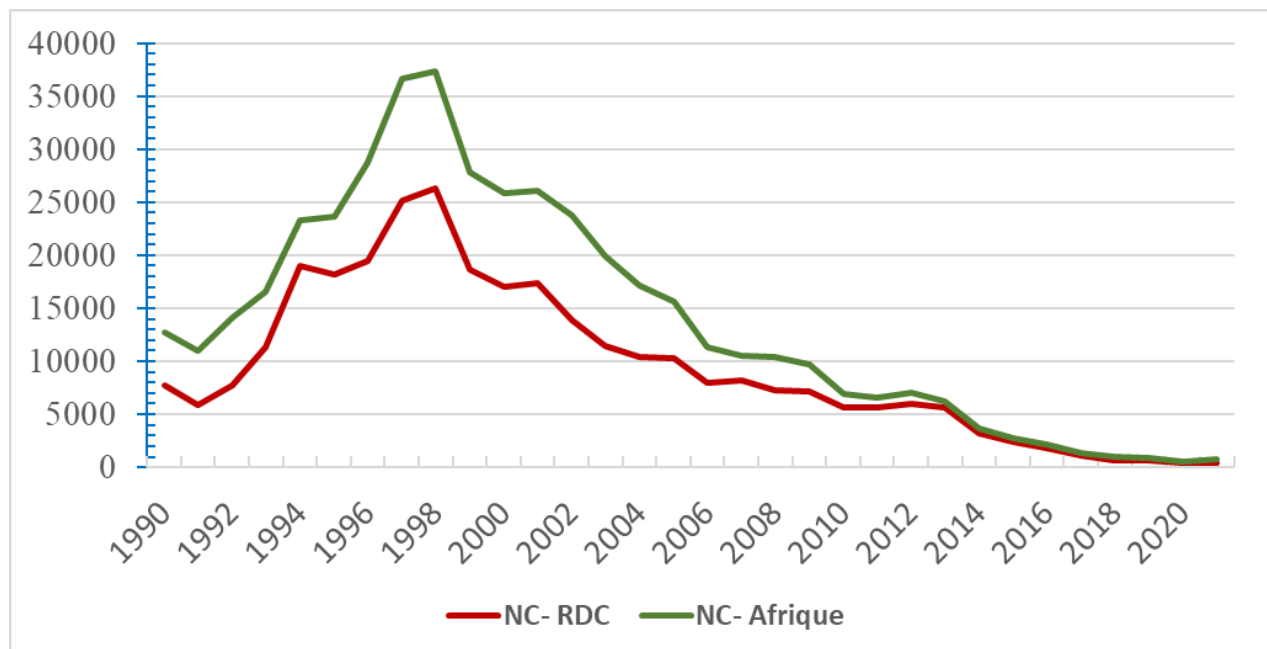


Fig.1 : Evolution des nouveaux cas THA rapportés en RDC et en Afrique entre 1990 et 2021.

Dans la période de 2016–2020, la population à risque au *T. brucei gambiense* a été estimée à 52 425 000 dans le monde dont plus de 80 % (n=42 740 000) de cette population se trouve en RDC.

En RDC, selon les estimations de l’OMS pour la période de 2016-2020, la population à risque est répartie en 4000 habitants sont à très haut et haut risque, 2 471 000 habitants sont à risque modéré et 40 265 000 habitants sont à très faible et faible risque. En RDC, 42 % (n=42 740 000 ; N= 101 769 000 hab. estimées par Landscan) de la population sont à risque pour la THA (Jose R Franco et al, 2022)

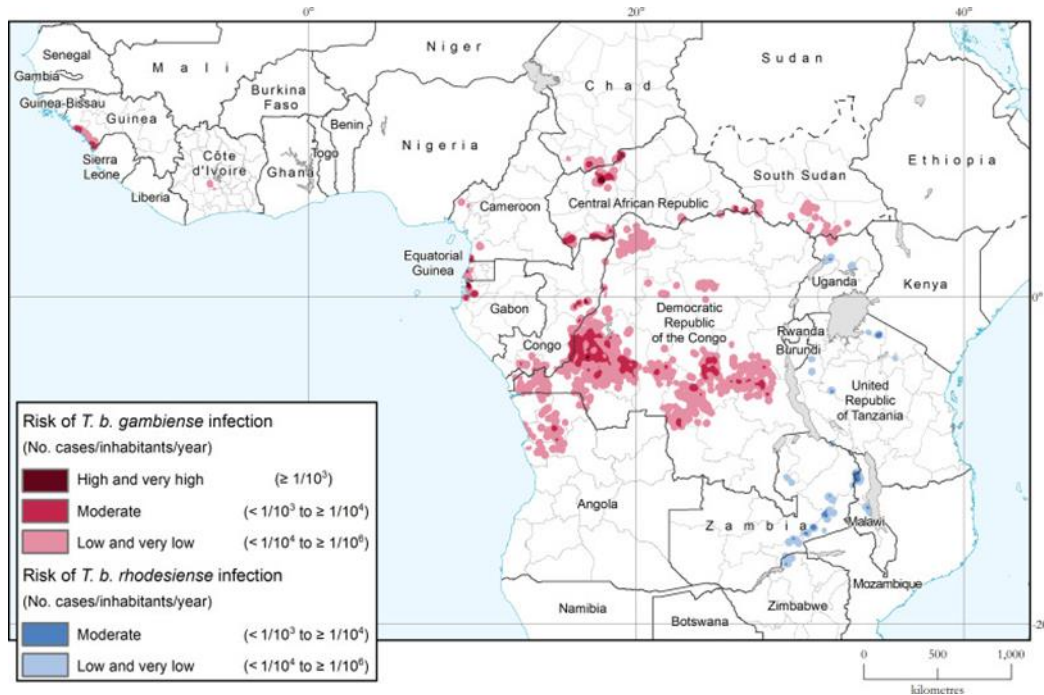


Fig. 2 : Aires à risque pour l’infection THA dans la période de 2016-2020 (Jose R Franco et al. 2022
The elimination of human African trypanosomiasis: Achievements in relation to WHO road map targets for 2020, PLoS Negl Trop Dis).

Depuis l’année 2012, La THA est inscrite sur la feuille de route de l’OMS pour les MTN dont l’élimination et /ou l’éradication sont possible. On note une diminution considérable de nombre de cas THA ces dix dernières années en Afrique de manière générale et en RDC en particulier.

En RDC les cas sont passés de 5 820 en 2013 à 516 cas en 2022. L’objectif actuel est d’arrêter la transmission de la THA d’ici 2030 avec comme objectif intermédiaire d’éliminer la THA comme problème majeur de santé publique.

Les stratégies de l’élimination de la THA se résument essentiellement en détection précoce des cas, le traitement comme stratégie principale et le contrôle du vecteur comme stratégie secondaire pour la *T. brucei gambiense*.

En RDC, la détection précoce de cas a été réalisée en dépistage actif avec des structures mobiles (UM et MUM) et en dépistage passif avec des structures sanitaires fixes des zones de santé qui ont intégré le dépistage, le diagnostic et le traitement des malades dans leur paquet d'activités (HGR et CS).

En 2023, le dépistage actif a été fait en combinant plusieurs approches : (1) Le dépistage actif classique avec les unités mobiles (UM). C'est un dépistage de masse organisé par les UM dans les villages endémiques selon une programmation annuelle déjà élaborée basée sur les évidences épidémiologiques suivant les recommandations de l'OMS. (2) Le dépistage actif classique avec les mini-unités mobiles (MUM). Il s'agit d'un dépistage porte à porte réalisé par les MUM dans les villages endémiques surtout d'accès difficile en suivant une programmation annuelle déjà élaborée. (3) Le dépistage réactif avec la MUM. C'est un dépistage réalisé dans un village (non planifié en dépistage actif classique) où l'on vient d'identifier un cas en dépistage passif par une structure sanitaire fixe. (4) Les enquêtes de prospection médicale dans les foyers historiques non surveillés ni activement ni passivement.

Le dépistage passif n'a pas été organisé de manière systématique dans toutes les provinces endémiques. Il y a des provinces (Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi, et Tshopo) qui ont fait la surveillance par sites sentinelles avec l'appui de l'OMS. D'autres provinces (Kasaï oriental, Lomami et Sankuru) ont réalisé la surveillance passive dans le cadre d'un projet pilote qui vise l'intégration de la THA dans les soins de santé primaire dans les formations sanitaires de la zone de santé avec l'appui de l'IMT Anvers. D'autres provinces encore (Kwilu, Mayindombe, Kwango, Lomami, Kasaï oriental, Kasaï Central et Kasaï) ont bénéficié d'un appui ponctuel aux structures qui traitent avec le Fexinidazole dans le cadre du projet d'accès au traitement (la pharmacovigilance) avec l'appui de DNDi.

En RDC, le contrôle du vecteur est une stratégie complémentaire au dépistage, diagnostic et traitement des malades. Cette stratégie est encore faiblement implémentée dans les provinces endémiques. Actuellement, elle est réalisée uniquement dans deux provinces (Kwilu et Mayindombe) avec l'appui technique et financier de LSTM et IMT Anvers. On a combiné deux approches, l'approche verticale et l'approche horizontale (communautaire). L'approche verticale a été réalisée le long des rivières dans les foyers THA par les agents formés dans les zones de santé. Cette approche vise à réduire la densité des glossines pour interrompre la transmission de la THA dans le foyer. L'approche communautaire est implantée par les membres de la communauté dans les lieux probables de contact homme-mouche. Cette approche vise à arrêter le contact homme-mouche dans les aires d'activités humaines pour empêcher la transmission de la THA. A ces stratégies de base on ajoute les stratégies d'appui : le renforcement des capacités des personnes impliquées dans la surveillance passive et active de la THA, la recherche opérationnelle, la communication pour le changement de comportement et le suivi des activités.

2. Organisation de la lutte contre la THA en RDC

La lutte contre la Trypanosomiose Humaine Africaine (THA) en République Démocratique du Congo (RDC) est organisée par le Programme National de Lutte contre la THA (PNLTHA) qui est un programme spécialisé du Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Préventions. La direction nationale du PNLTHA est basée à Kinshasa (n° 1, Boulevard Triomphal croisement Avenue de la Libération, dans la Commune de Kasa-Vubu, B.P. 7.782 – KINSHASA 1.

2.1. Textes juridiques de création et historique du PNLTHA

Le PNLTHA a évolué depuis sa création en 1968 par ordonnance présidentielle, sous l'appellation du Bureau Central de la Trypanosomiose (BCT) jusqu'en 2003.

Depuis sa création, plusieurs textes juridiques ont régi la lutte contre la THA en RDC à savoir :

- La décision présidentielle du 28 Mars 1968 demandant à la Commission Présidentielle de Secours d'organiser en son sein le Bureau Central de la Trypanosomiose Humaine Africaine.
- L'ordonnance présidentielle n° 68/221 du 4 juillet 1968 portant cadre organique du Bureau Central de la Trypanosomiose.
- La lettre n° BPR/CC/0767/75 du 22 juillet 1975 sur décision du Président de la République : le BCT est placé sous la tutelle du Ministère de la Santé Publique comme service spécialisé.
- L'arrêté Départemental n° BUR/CE/029/88 du 30 Mars 1988 déterminant la structure organisationnelle de la Direction du BCT.
- L'arrêté Départemental n° BUR/CE/SP/002/90 modifiant et complétant celui du 30 Mars 1988.
- L'arrêté Ministériel n° 1250/CAB/MIN/S/AJ/CK/022/99 portant création d'un comité de concertation du BCT en date du 24/11/99.
- L'arrêté Ministériel n° 1250/CAB/MIN.S/16/2003 portant création et organisation d'un Programme National de Lutte contre la Trypanosomiose Humaine Africaine (PNLTHA).

Alors qu'à sa création (BCT) il était directement lié à la Présidence de la République, le PNLTHA est actuellement sous tutelle du Ministère de la Santé Publique.

Plusieurs Directeurs se sont succédé à la tête de ce programme depuis sa création :

- 1968-1975 : Dr BURKE⁺,
 - 1975-1987 : Dr J RUPPOL,
 - 1987-1989 : Dr KAZYUMBA LIBALA⁺,
 - 1989-1996 : Dr Florent EKWANZALA⁺,
 - 1996-2003 : Dr Constantin MIAKA MIA BILENGE⁺,
 - 2003-2012 : Dr. Victor KANDE BETU KU MESO,
 - 2012-2017 : Crispin LUMBALA wa MBUYI,
 - 2017 à ce jour : Éric MWAMBA MIAKA
- + : décédé.

2.2. Politique Nationale de lutte contre la THA en RDC

La politique en matière de lutte contre la THA en RDC est dictée par le document de politique sectorielle dont la dernière révision date de l'année 2016. Entre 2016 et 2023, il y a eu plusieurs avancés dans le

domaine du dépistage/diagnostic et traitement de la THA dont la nécessité de revisiter cette politique sectorielle en intégrant les évidences scientifiques du moment.

Au regards des différents textes le créant, le PNLTHA a pour mission d'organiser et de coordonner l'ensemble des activités de lutte contre la THA sur toute l'étendue de la RDC.

La vision du PNLTHA est de voir une population congolaise en bonne santé, productive et prospère, libérée du fardeau socio-économique de la THA.

La mise en œuvre de la politique de lutte contre la THA en RDC a ainsi pour but de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité dues à la THA à un niveau compatible avec une vie productive des populations vivant dans les zones à risque de transmission de la maladie (moins d'un malade pour 10 000 habitants). L'objectif spécifique vise à contribuer à l'objectif d'éliminer la THA comme problème majeur de santé publique en RDC et d'arrêter sa transmission en 2030.

Les stratégies préconisées pour atteindre ces objectifs et couper la chaîne de transmission de la maladie se résument principalement en dépistage précoce et traitement des malades. On associe le contrôle du vecteur comme stratégie secondaire. Les UM font le dépistage actif avec le CATT et les MUM avec le TDR. Les HGR et les CS organisent le dépistage passif avec le TDR qui sont des tests individuels et thermostables ne nécessitant pas la chaîne de froid.

La politique nationale recommande la mise en évidence du parasite dans un liquide biologique avant la mise du malade sous traitement. Les principaux examens de confirmation parasitologique sont l'examen du suc ganglionnaire si présence des ganglions typiques et la mini-colonne (mAECT). On peut aussi faire l'examen de LCR en cas de forte suspicion clinique avec des tests sensibles négatifs. La trypanolyse et les tests moléculaires ne sont pas encore utilisés en routine. Après confirmation, tout cas de THA est mis sous traitement suivant le guide de traitement de l'OMS. Le contrôle du vecteur est réalisé avec les petits écrans imprégnés d'insecticides et des pièges pyramidaux.

2.3. Structures et organisation

Le PNLTHA est structuré en 3 niveaux suivant la pyramide sanitaire : central, intermédiaire et périphérique ou opérationnel.

2.3.1. Niveau central

Le niveau central est constitué de la Direction du PNLTHA. Il est piloté par un directeur du programme qui est secondé par un directeur adjoint. Le pilier de la Direction est constitué de 5 divisions : (1) Administration et finances, (2) surveillance épidémiologique et formation, (3) recherche et laboratoire, (4) logistique, (5) Planification, suivi et évaluation, comme le montre l'organigramme en annexe. La division chargée de la Planification, suivi et évaluation est chapeautée par le Directeur Adjoint.

Le niveau central a un rôle stratégique, normatif et de coordination. Il assure un appui stratégique ainsi que la coordination des activités de lutte au niveau de la RDC.

A cet effet, il est chargé :

- D'élaborer la politique de lutte contre la THA en RDC

- De définir les stratégies de lutte, d'élaborer les normes et les instructions en rapport avec la lutte contre la THA en RDC
- De coordonner les activités de lutte contre la THA en RDC y compris le suivi et l'évaluation
- De mobiliser les ressources nécessaires pour assurer la lutte contre la THA en RDC

2.3.2. Niveau intermédiaire

Le niveau intermédiaire ou encore le niveau provincial est constitué par les différentes coordinations provinciales de lutte contre la THA (CPLTHA). Le PNLTHA possède 10 coordinations provinciales de lutte contre la THA.

Les CPLTHA ont un rôle dans la planification des activités de lutte en province ainsi qu'un appui technique et logistique à la mise en œuvre des activités au niveau périphérique ou opérationnel.

Chaque CPLTHA est dirigée par un Médecin Coordonnateur provincial et ou un infirmier superviseur provincial.

Voici la liste des différentes CPLTHA en RDC et les ZS qu'elles couvrent :

1. La CPLTHA Kinshasa et Kongo Central : elle couvre deux provinces (Kinshasa et Kongo Central), 65 ZS dont 23 ZSE (5 ZSE à Kinshasa et 18 ZSE au Kongo Central). Le MCP est basé à Kinshasa et le superviseur provincial à Matadi.
2. La CPLTHA Bandundu-Nord : elle couvre deux provinces (Kwilu et Mai Ndombe), 20 ZS dont 17 ZSE). Son siège est à Bandundu-Ville.
3. La CPLTHA Bandundu-Sud : elle couvre deux provinces (Kwilu et Kwango), 32 ZS dont 20 ZSE. Son siège est à Kikwit.
4. La CPLTHA Equateur Nord : elle couvre trois provinces (Mongala, Nord Ubangi et Sud Ubangi), 39 ZS dont 14 ZSE. Son siège est à Bwamanda.
5. La CPLTHA Equateur Sud : elle couvre deux provinces (Equateur et Tshuapa), 30 ZS dont 22 ZSE. Son siège est à Mbandaka.
6. La CPLTHA Kasai-Oriental : elle couvre deux provinces (Kasai Oriental et Lomami), 35 ZS dont 26 ZSE. Son siège est à Mbuji-Mayi.
7. La CPLTHA Sankuru : elle couvre une province (Sankuru), 16 ZS dont 5 ZSE. Son siège est à Wembo-Nyama.
8. La CPLTHA Kasai-Occidental : elle couvre deux provinces (Kasai Central et Kasai), 44 ZS dont 25 ZSE. Son siège est à Kananga.
9. La CPLTHA Maniema-Katanga : elle couvre trois provinces (Maniema et Haut Lomami et Lomami), 45 ZS dont 13 ZSE. Son siège est à Kasongo
10. La CPLTHA Tshopo : elle couvre une province (Tshopo), 23 ZS dont 16 ZSE. Son siège est à Isangi.

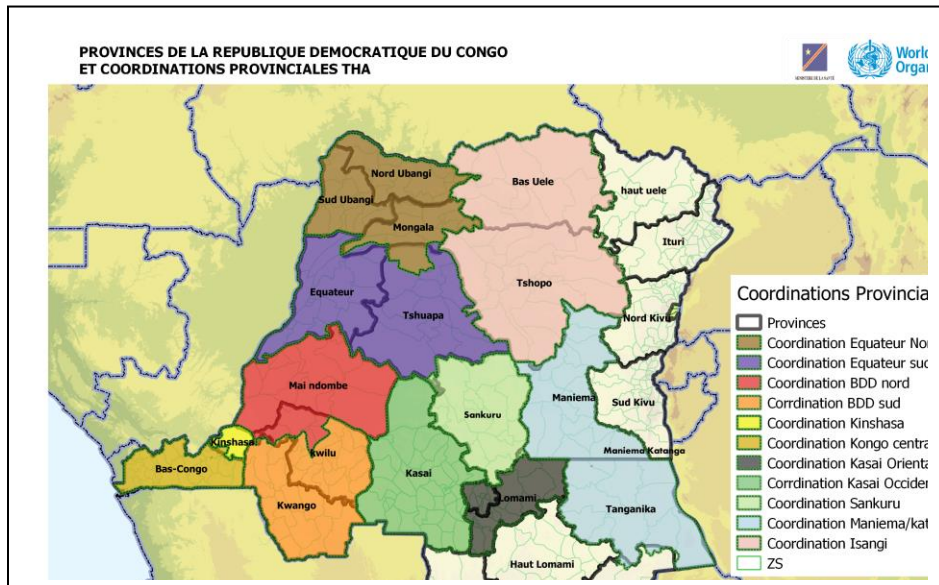


Fig. 3 : Carte de la RDC qui montre les rayons d'action des coordinations provinciales

La coordination de Tshopo est une mini-coordination qui ne couvre pas les provinces d'Ituri, de haut Uele et une bonne partie de bas Uele.

2.3.3. Niveau périphérique ou opérationnel

On trouve à ce niveau des Equipes Cadres des Zones de Santé endémiques, des structures spécialisées du PNLTHA (UM et MUM) et les structures polyvalentes (HGR et CS) des ZS ayant intégré les activités de lutte contre la THA. Ces différentes structures jouent chacune un rôle spécifique avec un paquet d'activités de lutte contre la THA bien défini.

Les Unités mobiles (UM) : elles organisent un dépistage de masse dans les villages endémiques. C'est une équipe constituée de 6-8 personnes qui se déplacent en véhicule dans les villages endémiques pour examiner toute la population à risque. L'UM fait 20 jours d'itinérances chaque mois pendant 11 à 12 mois dans l'année. Elle peut examiner 5000 à 6000 personnes par mois.

Les Mini-Unités mobiles (MUM) : elle est constituée de deux personnes (un dépisteuse et un dépisteuse-confirmateur) qui se déplacent chacun à moto dans les villages endémiques surtout d'accès difficile pour examiner à domicile toute la population à risque. La MUM fait aussi 20 jours d'itinérance chaque mois et peut examiner 2500 à 3000 personnes par mois.

Les formations sanitaires fixes de la zone de santé (HGR et CS) : elles font le dépistage passif de la THA et traitement des cas.

2.4. Ressources humaines, matérielles et financières

2.4.1. Ressources humaines

Le PNLTHA a fonctionné en 2023 avec 439 agents dont 17 % au niveau central et 83 % au niveau intermédiaire et périphérique. 54 % (n= 239) des agents du PNLTHA sont des personnels techniques et 46 % (n=200) administratifs. Le sexe ratio homme-femme est de 5,5.

Tableau 1 : Répartition des agents du PNLTHA par coordination provinciale en 2023

N ^o	Coordinations	Administratifs	Professionnel de santé	Médecins	Total
1	Bandundu Nord	29	19	1	49
2	Bandundu Sud	28	20	1	49
3	Equateur Nord	13	18	1	32
4	Equateur Sud	14	10	1	25
5	Kasai occidental	16	14	1	31
6	Kasai Oriental	22	36	1	59
7	Sankuru	5	6	1	12
8	Maniema Katanga	16	20	0	36
9	Kongo central	7	12	0	19
10	Kinshasa	4	19	1	24
11	Prov. Orientale	9	19	0	28
12	Coord. Nationale	37	16	22	75
Total		200	209	30	439

2.4.2. Ressources matérielles, intrants de dépistage/diagnostic et trypanocides

2.4.2.1. Intrants de dépistage / diagnostic

Tableau 2 : Tests de dépistage dans les coordinations provinciales et le niveau central en 2023

N°	Coordinations THA	CATT (flacon)			TDR (test)		
		Stock début 2023	Reçu l'année 2023	Stock fin 2023	Stock début 2023	Reçu l'année 2023	Stock fin 2023
1	Bandundu Nord	1350	9066	2111	68000	138000	34000
2	Bandundu Sud	0	9693	2883	61560	141040	70350
3	Equateur Nord	920	4320	1150	2080	58000	14120
4	Equateur Sud	460	0	460	31.680	68.000	16.000
5	Kasai occidental	1141	2021	725	60165	44687	50796
6	Kasai Oriental	1250	4193	0	6000	52000	0
7	Sankuru	101	510	130	0	600	0
8	Maniema Katanga	0	1969	0	10040	10000	8000
9	Kongo central	0	400	41	26350	47275	9059
10	Kinshasa	174	995	397	3680	2000	320
11	Tshopo	164	1480	278	567	34000	14000
	S /t coord. Prov.	5560	34647	8175	238442	527602	200645
	Coord. Nationale	2727	31974	2096	86960	1229800	15160

Tableau 3 : Tests de diagnostic dans les coordinations provinciales et le niveau central en 2023

N°	Coordinations THA	mAECT		
		Stock début 2023	Stock reçu l'année 2023	Stock fin 2023
1	Bandundu Nord	180	4300	2420
2	Bandundu Sud	250	3380	160
3	Equateur Nord	760	620	218
4	Equateur Sud	360	200	320
5	Kasai occidental	344	812	303
6	Kasai Oriental	2055	1320	1000
7	Sankuru	60	180	60
8	Maniema Katanga	32	9	31
9	Kongo central	80	700	480
10	Kinshasa	20	20	71
11	Tshopo	60	100	40
	Sous total coord. Prov.	4201	11641	5103
	Coord. Nationale	4000	16000	5760

2.4.2.2. Trypanocides / Trypanostatiques

Tableau 4 : Fexinidazole et Pentamidine dans les coordinations provinciales et le niveau central en 2023

N°	Coordinations THA	Fexinidazole			Pentamidine		
		Stock début 2023	Stock reçu l'année 2023	Stock fin 2023	Stock début 2023	Stock reçu l'année 2023	Stock fin 2023
1	Bandundu Nord	9	49	22	4	31	28
2	Bandundu Sud	75	116	23	14	35	35
3	Equateur Nord	0	4	2	104	8	112
4	Equateur Sud	11	7	13	39	7	46
5	Kasai occidental	11	53	6	16	91	9
6	Kasai Oriental	6	40	6	9	47	49
7	Sankuru	0	42	16	58	7	7
8	Maniema Katanga	21	29	7	0	7	7
9	Kongo central	0	7	3	4	7	11
10	Kinshasa	0	6	3	0	35	25
11	Tshopo	0	7	5	21	35	0
	Sous total coord. Prov.	133	360	106	269	310	329
	Coord. Nationale	20	802	354	0	490	69

Tableau 5 : NECT dans les coordinations provinciales et le niveau central en 2023

N°	Coordinations THA	Eflornithine			Nifurtimox		
		Stock début 2023	Stock reçu l'année 2023	Stock fin 2023	Stock début 2023	Stock reçu l'année 2023	Stock fin 2023
1	Bandundu Nord	270	500	77	33	185	21
2	Bandundu Sud	62	391	170	445	1950	818
3	Equateur Nord	30	150	120	0	800	600
4	Equateur Sud	70	15	70	200	0	0
5	Kasai occidental	18	216	108	120	1140	300
6	Kasai Oriental	14	195	110	77	975	638
7	Sankuru	12	12	8	0	75	0
8	Maniema Katanga	0	0	0	0	0	0
9	Kongo central	0	15	15	0	75	75
10	Kinshasa	0	0	0	0	0	0
11	Isangi	0	90	90	0	300	300
	Sous total coord. Prov.	476	1584	768	875	5500	2752
	Coord. Nationale	40	2439	652	0	9300	1800

2.4.2.3. Matériel roulant

Tableau 6 : Matériels roulants au niveau central, intermédiaire et périphérique en 2023

N°	Coordinations THA	Véhicules roulants		Motos		Canots rapides		Pirogues motorisés	
		Coord.	UM	Coord.	UM	Coord.	MUM	Coord.	UM
1	Bandundu Nord	2	5	4	10	1	3	0	0
2	Bandundu Sud	2	6	6	11	0	0	0	2
3	Equateur Nord	1	3	2	2	0	0	0	0
4	Equateur Sud	1	0	1	4	0	0	0	0
5	Kasai occidental	1	3	2	2	0	0	0	0
6	Kasai Oriental	1	4	2	2	0	0	1	0
7	Sankuru	1	0	1	2	0	0	0	0
8	Maniema	0	2	2	0	0	0	0	2
9	Katanga	1	0	0	3	0	0	0	0
10	Kongo central	0	1	0	0	1	0	0	0
11	Kinshasa	0	1	1	2	0	0	0	1
12	Tshopo	0	1	1	2	0	0	0	1
12	Coord. Nationale	2							
	Total	12	25	21	38	2	3	1	5

Un grand nombre des véhicules roulants au niveau des coordinations provinciales et des UM sont en très mauvais états avec des pannes à répétition (immobilisation des véhicules plusieurs jours) qui impacte négativement sur le déplacement des structures mobiles qui font le dépistage de masse.

2.4.3. Ressources financières

Tableau 7 : Appui des partenaires techniques et financiers en 2023

N°	Partenaires	Type d'appui	Montant global en en USD
1	DGD via IMT (FA5)	Appui à la lutte contre la Trypano dans les Coord. Prov. (EQS,EQN, Kin, Isangi, MNK,Sankuru,KC, KOCC) et nationale.	652 889
2	BMGF via IMT (TrypElim)	Appui à la lutte contre la Trypano dans les Coord. Prov. (BDDN, BDDS et KOR) et nationale.	1 473 570
3	OMS	Appui à la lutte contre la Trypano dans les Coord. Prov. (EQN, KOCC et Isangi) et nationale.	612 286
4	FIND	Appui à la lutte contre la Trypano dans les Coord. Prov. (KC) et nationale.	37 430
5	DNDi	Appui à la lutte contre la Trypano	48 192
6	Gouvernement RDC	Infrastructures et salaires	
Total			2 824 367

Le programme national de contrôle de la THA a bénéficié aussi d'autres appuis financiers comme l'appui au déploiement des trypanocides dans toutes les coordinations provinciales, l'appui à l'intégration de la THA dans les SSP dans deux coordinations provinciales (KOR et Sankuru), l'appui à l'accès au traitement dans les structures qui utilisent le Fexinidazole (4 coordinations provinciales), l'appui à la célébration de la journée THA et autres.

3. Détection précoce et traitement des cas

3.1. Villages programmés en dépistage actif avec les UM et MUM

Tableau 8 : Structures mobiles impliquées dans le dépistage de la THA en 2023

N°	Coordination Provinciale	Nbre ZSE	Nbre ASE	Nbre UM	Nbre MUM
1	Bandundu Nord	17	189	6	5
2	Bandundu Sud	20	289	6	6
3	Equateur Nord	14	50	3	1
4	Equateur Sud	22	19	0	2
5	Kasai occidental	25	213	3	1
6	Kasai Oriental	26	74	4	1
7	Sankuru	5	56	1	1
8	Maniema Katanga	13	245	2	0
9	Kongo central	18	26	0	1
10	Kinshasa	5	12	1	0
11	Tshopo	16	23	1	0
Total		181	1196	27	18

Le programme national de contrôle de la THA a fonctionné en 2023 avec 27 UM et 18 MUM pour organiser la surveillance active de la THA dans les provinces endémiques. 44 % des UM et 61 % des MUM sont dans l'ancienne province du Bandundu (Kwilu, Maindombe et Kwango) qui reste la province la plus endémique de la THA en RDC avec la moitié (56%) de NC en 2023. La surveillance passive a été assurée principalement par des structures sanitaires fixes dans les aires endémiques qui ont bénéficié d'un appui technique et financier soit dans le cadre de l'accès au traitement par le Fexinidazole avec DNDi, soit comme sites sentinelles avec l'OMS, soit encore comme projet pilote d'appui à l'intégration de la THA dans les SSP avec IMT Anvers.

Tableau 9 : Villages endémiques programmés et visités en DA par les UM et MUM en 2023

N°	Coordination Provinciale	Nbre ZSE	Nbre Villages endémiques (liste 1 et 2)	Nbre Villages programmés	Villages progr. Visités	Villages non progr. Visités	% des villages progr. visités
1	Bandundu Nord	17	319	265	262	0	98,9
2	Bandundu Sud	20	403	397	383	6	96,5
3	Equateur Nord	14	81	81	78	5	96,3
4	Equateur Sud	22	41	81	72	9	88,9
5	Kasai occidental	25	207	249	211	0	84,7
6	Kasai Oriental	26	128	262	250	0	95,4
7	Sankuru	5	107	107	71	0	66,4
8	Maniema Katanga	13	104	83	54	0	65,1
9	Kongo central	18	26	29	25	18	86,2
10	Kinshasa	5	29	29	17	6	58,6
11	Tshopo	16	70	60	58	2	96,7
Total		181	1515	1643	1481	46	90,1

Le nombre des villages endémiques à visiter en dépistage actif par les UM et les MUM diminue progressivement avec la diminution de nombre cas ces dernières années. La liste des villages endémiques en 2023 était de 1515 villages. On avait programmé 1643 villages à visiter en DA (la liste des villages endémiques était complétée avec des villages historiques pour atteindre la capacité des UM et MUM). 90 % des villages programmés étaient visités en 2023. Les zones de santé endémiques de Kwamouth, Bolobo et Yumbi n'ont pas été couvertes en surveillance active en 2023 à cause de l'insécurité.

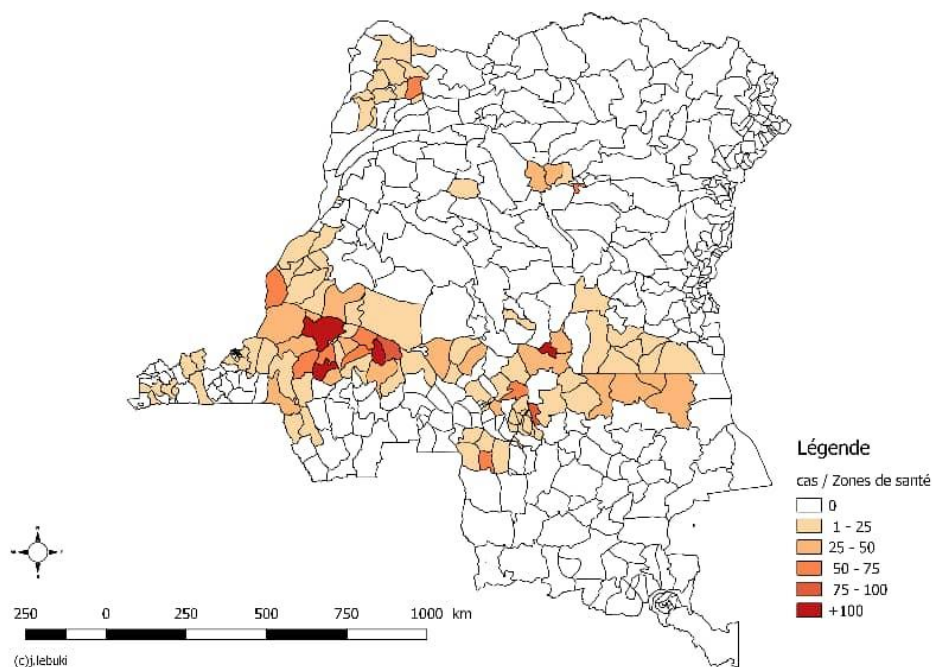


Fig. 4: Carte de zones de santé endémiques en RDC dans la période de 2018 - 2022

Cette carte montre les zones de santé endémiques les cinq dernières années qui doivent être surveillées activement en 2023 tout en laissant une surveillance passive continue. À côté de ces aires endémiques, on trouve aussi des villages historiques qui doivent être prospectés dans l'objectif d'éliminer la THA comme problème de santé publique majeur en RDC avant d'envisager l'arrêt de la transmission d'ici 2030.

3.2. Dépistage et diagnostic de la THA

Tableau 10 : Population examinée au CATT par coordination provinciale en 2023

N ^o	Coordination THA	DA			DP		
		CATT réalisé	CATT +	Proportion CATT + (%)	CATT réalisé	CATT +	Proportion CATT + (%)
1	Bandundu Nord	382670	359	0,09	9386	4	0,04
2	Bandundu Sud	347020	961	0,28	7851	78	0,99
3	Equateur Nord	190211	362	0,19	0	0	0,00
4	Equateur Sud	0	0	0,00	0	0	0,00
5	Kasai occidental	119493	488	0,41	2370	6	0,25
6	Kasai Oriental	235948	1654	0,70	0	0	0,00
7	Sankuru	30387	87	0,29	0	0	0,00
8	Maniema Katanga	73327	26	0,04	0	0	0,00
9	Kongo central	25243	92	0,36	0	0	0,00
10	Kinshasa	35973	18	0,05	0	0	0,00
11	Tshopo	50266	402	0,80	1009	6	0,59
Total		1490538	4449	0,30	20616	94	0,46

En 2023, toute la population examinée (2 236 845) a été soumise à un test de dépistage sérologique (CATT ou TDR). 68% (n=1511154) de la population totale examinée étaient soumis au CATT et 32 % (n= 725691) au TDR. La proportion des CATT positif est de 0,3 % en DA et 0,46 % en DP. Le CATT est principalement utilisé en dépistage de masse avec les UM. Quelques structures fixes continuent à utiliser le CATT en surveillance passive dans les coordinations provinciales du Bandundu Nord et Sud, du Kasai occidental et dans la Tshopo.

Tableau 11: Population examinée au TDR par coordination provinciale en 2023

N°	Coordination THA	DA			DP		
		TDR réalisé	TDR +	Proportion TDR + (%)	TDR réalisé	TDR +	Proportion TDR + (%)
1	Bandundu Nord	160814	1110	0,69	65181	443	0,68
2	Bandundu Sud	157502	1756	1,11	12651	162	1,28
3	Equateur Nord	52009	225	0,43	6617	59	0,89
4	Equateur Sud	34717	159	0,46	11394	40	0,35
5	Kasai occidental	14793	87	0,59	42173	499	1,18
6	Kasai Oriental	48877	383	0,78	18924	446	2,36
7	Sankuru	24965	242	0,97	2213	75	3,39
8	Maniema Katanga	2116	1	0,05	3308	10	0,30
9	Kongo Central	28187	272	0,96	30848	349	1,13
10	Kinshasa	1080	1	0,09	834	17	2,04
11	Tshopo	234	7	2,99	6254	89	1,42
Total		525294	4243	0,81	200397	2189	1,09

En 2023, la proportion des TDR positif est de 0,81 % en DA et 1,1% en DP. Les TDR ont été utilisé en actif par les MUM qui font le dépistage porte à porte et en passif par les structures sanitaires fixes de la zone de santé.

Tableau 12 : Répartition de la population examinée et nombre de cas de THA par coordination provinciale en 2023

N°	Coordination Provinciale	PTR	PTE en DA	PTE total	NC en DA		NC en DP		NC total			T.P en DA (%)	T.I en DA (pr 10 ⁴)	T.I Gl (pr 10 ⁴)
					T ⁺	T ⁰	T ⁺	T ⁰	T ⁺	T ⁰	T ⁺ et T ⁰			
1	Bandundu Nord	571119	543484	618051	24	0	30	0	54	0	54	95,2	0,4	0,9
2	Bandundu Sud	611955	504522	525024	118	0	49	0	167	0	167	82,4	2,3	3,2
3	Equateur Nord	256023	242220	248837	2	0	3	0	5	0	5	94,6	0,1	0,2
4	Equateur Sud	53575	34717	46111	0	0	0	0	0	0	0	64,8	0,0	0,0
5	Kasai occidental	183946	134286	178829	44	0	34	0	78	0	78	73,0	3,3	4,4
6	Kasai Oriental	319247	284825	303749	13	0	5	18	18	18	36	89,2	0,5	1,2
7	Sankuru	79555	55352	57565	1	0	6	4	7	4	11	69,6	0,2	1,9
8	Maniema Katanga	104456	75443	78751	1	0	8	0	9	0	9	72,2	0,1	1,1
9	Kongo central	63092	53430	84278	0	0	0	0	0	0	0	84,7	0,0	0,0
10	Kinshasa	56369	37053	37887	1	0	7	0	8	0	8	65,7	0,3	2,1
11	Tshopo	65159	50500	57763	0	0	25	1	25	1	26	77,5	0,0	4,5
Total		2364496	2015832	2236845	204	0	167	23	371	23	394	85,3	1,0	1,8

T⁺ : Cas parasitologique (mise en évidence du trypanosome dans un liquide biologique)

T⁰ : Cas non parasitologique (trypanolyse positive et ou PCR positive).

On a examiné 2 236 845 personnes dont 90% (n= 2015832) en surveillance active. Un total de 394 NC a été diagnostiqué dont 52 % (n=204) en actif et 48% (n=190) en passif. 94% de cas ont été confirmée en mettant le parasite en évidence et 6 % sont de cas sérologiques avec trypanolyse positive. Les cas sérologiques ont été rapporté en passif dans le cadre du projet pilote d'appui à l'intégration du dépistage et diagnostic de la THA dans les formations sanitaires des zones de santé des provinces du Kasai oriental, Lomami et Sankuru. Un cas sérologique THA provient de la province du Bas Uele.

La participation de la population au dépistage actif en 2023 a variée de 65% pour la plus faible à l'Equateur sud à 95 % la plus élevée au Bandundu Nord et à l'Equateur Nord. Le taux de participation en DA est très faible en dessous de 80% dans les coordinations provinciales de l'Equateur sud, Kinshasa, Sankuru, Kasai occidental, Maniema Katanga et Tshopo. Plusieurs causes sont possibles et sont documentées dans des études anthropologiques. Le manque d'intérêt pour une maladie qui n'est plus perçue dans les communautés comme une menace (forte diminution de nombre de cas). Il faut penser à coupler le dépistage de la THA avec celui des autres maladies qui semblent être perçues comme une menace dans les communautés, ou encore trouver d'autres facteurs incitatifs.

En 2023, au niveau pays, le taux d'infection en DA est de 1 pour 10 000 personnes examinées. Il y a une forte régression de manière générale, mais ce taux reste élevé dans certaines coordinations provinciales comme celles du Bandundu sud (2,3 pour 10^4) et du Kasai occidental (3,3 pour 10^4). Dans certaines coordinations provinciales comme l'Equateur sud et le Kongo central, le taux d'infection est très bas depuis quelques années. Dans ces coordinations THA, on peut déjà commencer à envisager la documentation de l'élimination de la THA comme problème majeur de santé publique. Le programme national pourrait relancer des discussions avec l'OMS sur la possibilité de l'élimination de la THA coordination THA par coordination THA en RDC.

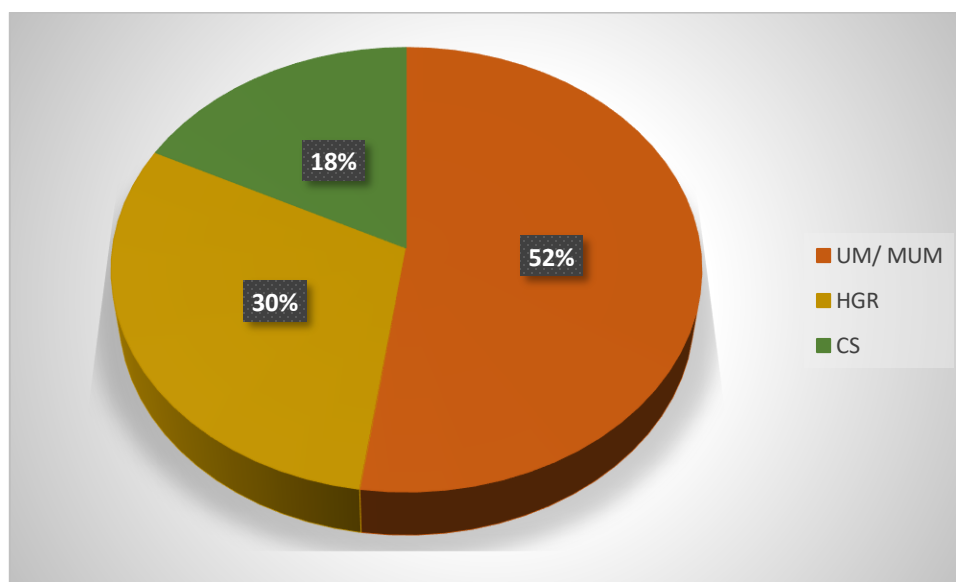


Fig. 5 : Proportion des NC THA diagnostiqués par structure de lutte en 2023

La fig.5 montre que 52 % des cas THA détectés en 2023 ont été diagnostiqué en dépistage actif par les structures mobiles (UM et MUM) et 48% en passif par les structures sanitaires fixes de la zone de santé (HGR et CS).

Tableau 13 : Nouveaux cas et leur premier mode de diagnostic en 2023

N°	Coordination THA	NC	PG +	mAECT +	LCR +	CTC +	TL +	PCR +	GE +	SF +	*Frottis +
1	Bandundu Nord	54	6	44	4	0	0	0	0	0	0
2	Bandundu Sud	167	23	130	8	0	0	0	0	6	0
3	Equateur Nord	5	1	3	1	0	0	0	0	0	0
4	Equateur Sud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kasai occidental	78	0	32	0	3	0	0	43	0	0
6	Kasai Oriental	36	2	13	3	0	18	0	0	0	0
7	Sankuru	11	3	2	2	0	4	0	0	0	0
8	Maniema Katanga	9	1	0	2	0	0	0	6	0	0
9	Kongo central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kinshasa	8	0	6	1	0	0	0	0	0	1
11	Tshopo	26	2	7	0	16	1	0	0	0	0
Total		394	38	237	21	19	23	0	49	6	1

*Frottis : diagnostic posé en Afrique du sud chez un patient de Kinshasa

60 % des cas diagnostiqués en 2023 sont en mini-colonne (mAECT). 12 % de cas diagnostiqués étaient fait avec la GE qui est une technique moins sensible, surtout avec cette baisse de la prévalence de la maladie. La GE comme premier mode de diagnostic a été réalisé dans deux provinces (le Kasai occidental et le Maniema Katanga). Au Kasai occidental même les UM continuent à réaliser la GE en dépistage actif au moment où la mini colonne est disponible.

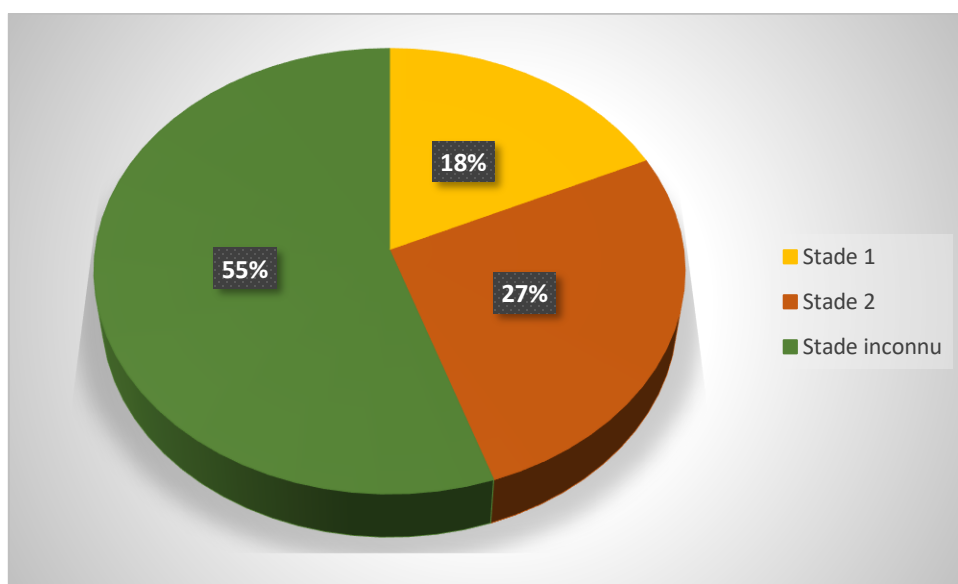


Fig.6 : Répartition des cas selon le stade de la maladie en 2023

55% des cas diagnostiqués ont un stade inconnu, ce qui montre qu'on a évité la ponction lombaire à plus de la moitié des patients. C'est une bonne évolution vers la suppression de la ponction lombaire de stadification de la maladie avant le traitement ; cette ponction lombaire constitue l'un des plus grands obstacles au dépistage de masse de la THA dans les villages endémiques.

Tableau 14 : Répartition des cas THA selon le stade de la maladie par coordination provinciale en 2023

N°	Coordinations THA	DA			DP		
		Stade 1	Stade 2	Stade inconnu	Stade 1	Stade 2	Stade inconnu
1	Bandundu Nord	1	6	17	0	14	16
2	Bandundu Sud	8	22	88	1	27	21
3	Equateur Nord	0	2	0	0	3	0
4	Equateur Sud	0	0	0	0	0	0
5	Kasai occidental	16	7	21	14	8	12
6	Kasai Oriental	3	3	7	0	3	20
7	Sankuru	0	0	1	0	1	9
8	Maniema Katanga	0	1	0	3	4	1
9	Kongo Central	0	0	0	0	0	0
10	Kinshasa	0	0	1	1	4	2
11	Tshopo	0	0	0	24	0	2
Total		28	41	135	43	64	83

18 % des cas diagnostiqués en 2023 sont au stade précoce de la maladie, ce qui indiquerait une infection récente. La transmission est encore active dans certains foyers. La majorité de cas du premier stade provient de deux coordinations provinciales (Kasaï occidental et la Tshopo). 38% des cas au Kasaï occidental sont au premier stade de la maladie et 42% au stade inconnu. Si on enlève les cas au stade inconnu, le ratio premier stade deuxième stade est de 2 au Kasaï occidental. A Tshopo, 92 % de cas diagnostiqués sont encore au stade 1. Dans ces deux provinces les foyers sont encore actifs, il faut penser à associer le contrôle du vecteur qui se fait pour le moment uniquement dans l'ancienne province du Bandundu.

3.3. Traitement des malades

Tableau 15 : Nombre de malades THA par coordination provinciale traités en 2023

N°	Coordination THA	Fixinidazole	Pentamidine	NECT	*Autres	Total NC traités	Total NC	Décès avant T ³	% NC traités	*NC T ³ 2024
1	Bandundu Nord	36	0	14	0	53	54	0	98	1
2	Bandundu Sud	121	2	33	3	156	167	2	95	9
3	Equateur Nord	0	0	5	0	5	5	0	100	0
4	Equateur Sud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kasai occidental	58	10	5	0	73	78	0	94	5
6	Kasai Oriental	25	1	7	0	33	36	0	92	3
7	Sankuru	11	0	0	0	11	11	0	100	0
8	Maniema Katanga	7	1	1	0	9	9	0	100	0
9	Kongo central	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kinshasa	3	1	3	0	7	8	0	88	1
11	Tshopo	2	24	0	0	26	26	0	100	0
Total		263	39	68	3	373	394	2	95	19

*NC T³ 2024 : NC de 2023 qui ne sont pas encore traités. Ils sont au nombre de 19 et seront récupérés et traités en 2024.

En 2023, on a diagnostiqué 394 NC dont 95 % (n=373 ; N=392) sont traités en 2023. On a connu deux décès avant le traitement.

Le reste des malades de l'année 2022 sans traitement, ont été tous récupérés et traités en 2023. Et donc la situation de traitement de 516 NC de 2022 est 100 % de traitement (n=512, N=512), on avait enregistré 4 décès avant le traitement. Parmi tous les 373 malades de 2023 qui sont traités, 23 sont des cas sérologiques traités avec Fexinidazole.

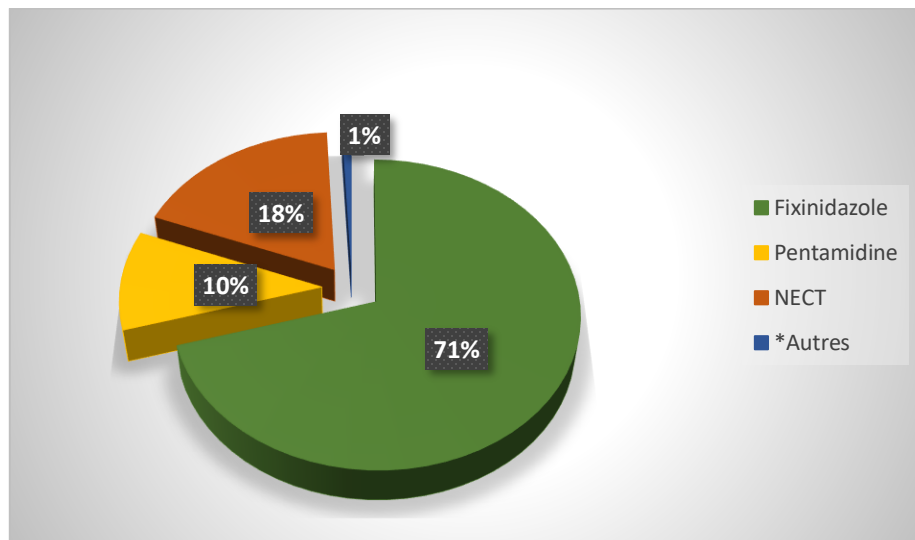


Fig.7 : Proportion des malades de 2023 traités par molécules de traitement.

71% des NC de 2023 ont été traités avec le Fexinidazole et 18% avec le NECT. Il y a trois malades qui ont été traités dans le cadre des études cliniques.

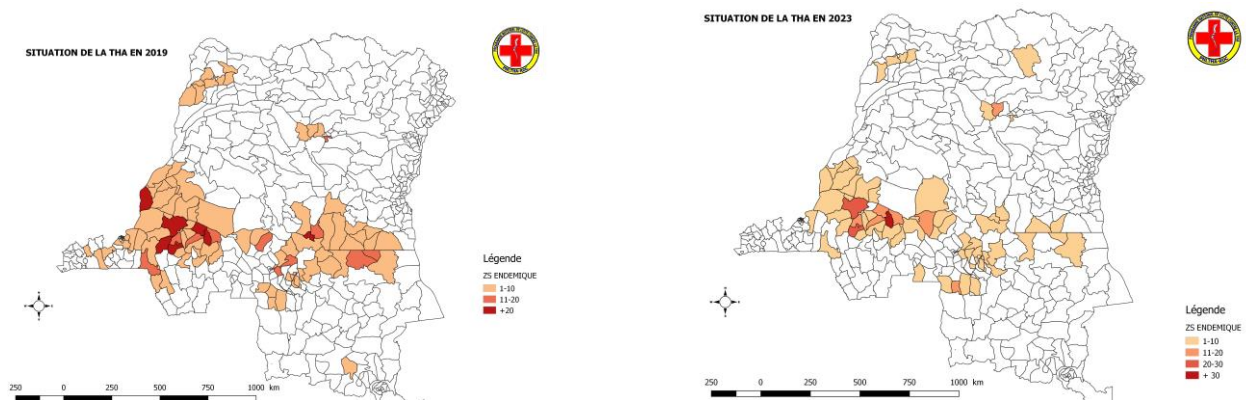


Fig 8 : Carte des zones de santé ayant notifiés au moins un cas de TMA en 2019 et **Fig 9** : Carte des zones de santé ayant notifiés au moins un cas de TMA en 2023.

En comparant les deux cartes, celle de 2019 et celle de 2023, on note clairement une diminution de nombre des zones de santé endémiques en 2023 qu'en 2019. La couleur foncée est en train de disparaître progressivement et donc la population à haut risque diminue aussi. Comme cette population à haut risque diminue fortement, la conséquence est que la TMA n'est plus ressentie comme une menace dans

les communautés, ce qui expliquerait en partie une baisse du taux de participation en DA (perçus comme une perte de temps). Il faut bien adapter cette surveillance active qui reste la stratégie principale pour éliminer la THA.

3.4. Tendances évolutives des cas de THA ces dernières années

3.4.1. Tendances en RDC

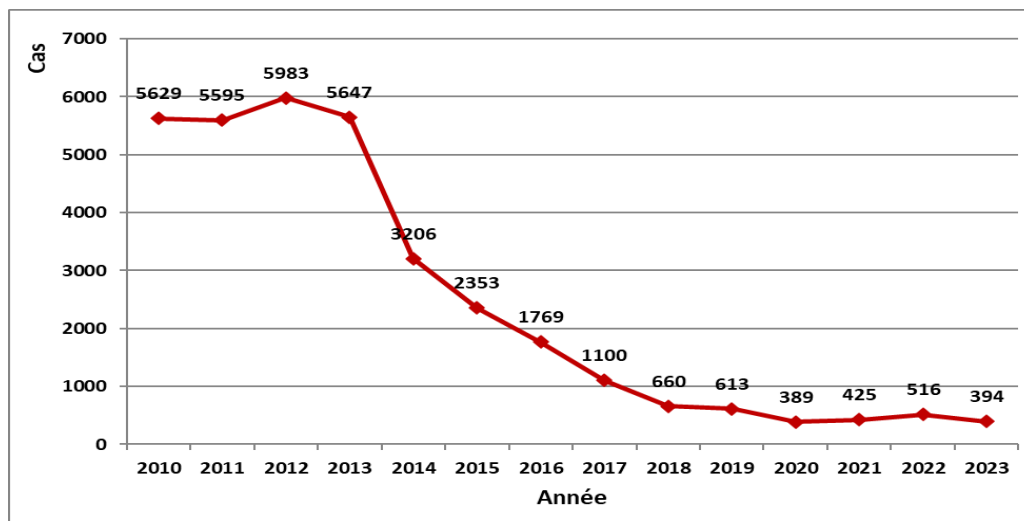


Fig. 10 : Evolution des NC en RDC entre 2010 et 2023.

De manière générale les cas ont diminué sensiblement en RDC et sont passés de 5629 NC en 2010 à 394 NC en 2023. Entre 2020 et 2023, on note une légère augmentation jusqu'en 2022 et ensuite une diminution de nombre des cas en 2023.

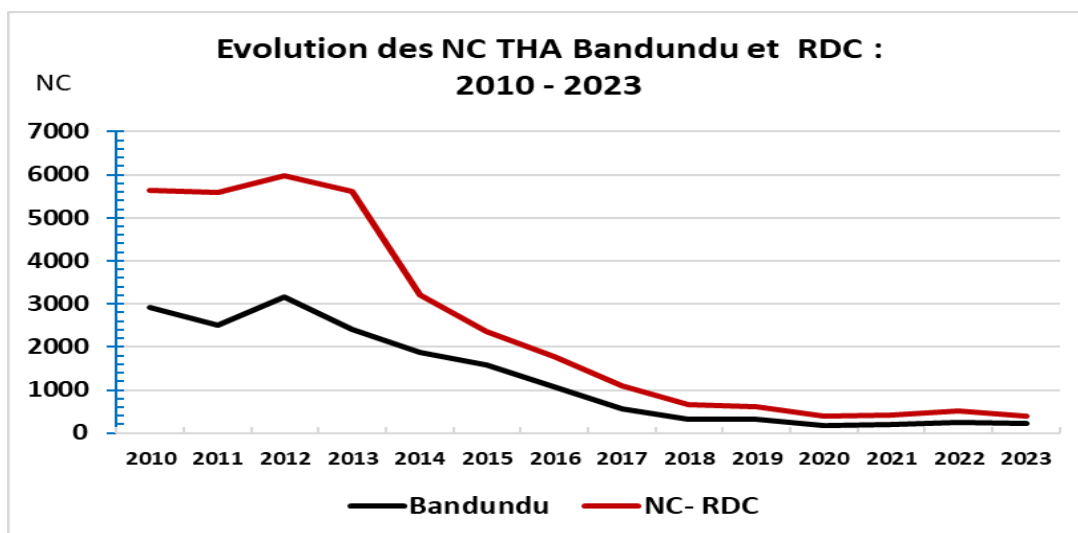


Fig. 11 : Evolution des NC THA dans l’ancienne province du Bandundu et en RDC entre 2010 et 2023.

En comparant la courbe des NC de la RDC avec celle de l’ancienne province de Bandundu qui est actuellement subdivisée en trois provinces (Kwilu, Maïdombe et Kwango), on constate que les deux courbes sont superposables. Plus de 50 % des cas de la RDC proviennent de cette province de Bandundu (56% de cas de la RDC en 2023).

3.4.2. Tendances dans les provinces endémiques

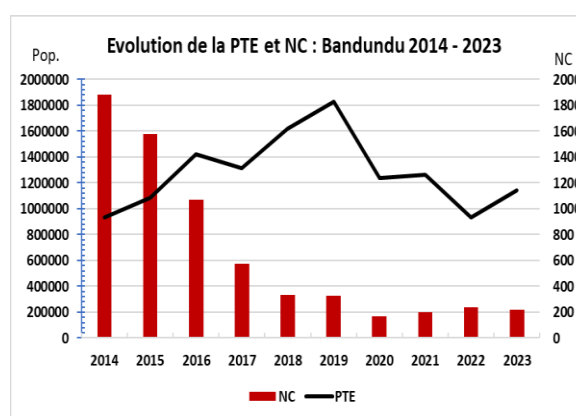
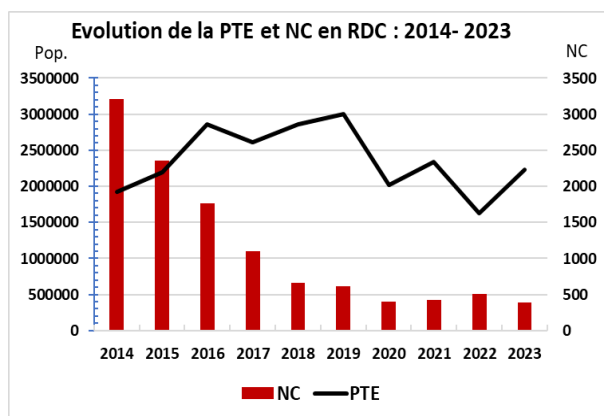


Fig. 12 : Evolution de la PTE et NC en RDC entre 2014 et 2023 et **Fig 13** : Evolution de la PTE et NC dans l’ancienne province du Bandundu entre 2014 et 2023.

La population totale examinée varie en dent de scie en RDC comme au Bandundu. On note un pic de 3 millions en 2019 en RDC et la même année on constate un pic de 1,8 millions au Bandundu. Et donc non seulement la courbe de NC est superposable mais aussi les courbes des populations examinées suivent les mêmes tendances. C'est aussi la province qui a un nombre élevé des structures mobiles qui organisent le dépistage actif, soit 44% (n=12, N=27) des UM et 61% (n=11, N=18) de MUM. La province du Bandundu bien que les cas sont en diminution, elle reste actuellement la province la plus endémique de la RDC. Cette province est subdivisée en deux coordinations provinciales (Bandundu Nord et Bandundu Sud). En 2023, 76% (n=167, N=221) de NC sont venus de la coordination du Bandundu sud.

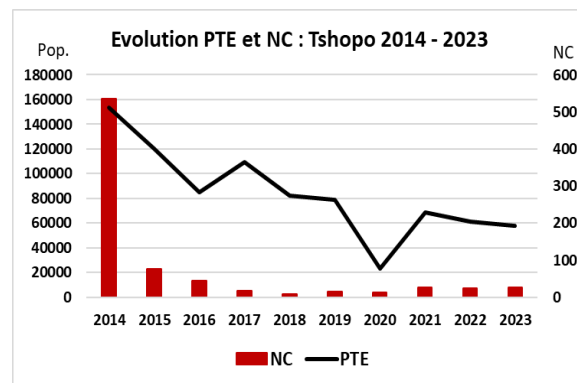
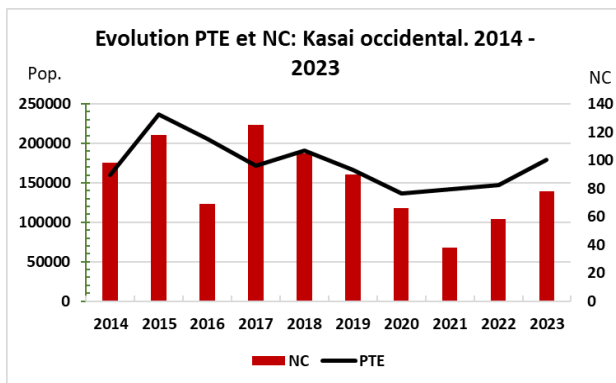


Fig. 14 : Evolution de la PTE et NC au Kasai occidental entre 2014 et 2023 et **Fig 15** : Evolution de la PTE et NC à Tshopo (Isangi) entre 2014 et 2023.

Si de manière générale le nombre de cas est en diminution au niveau pays, au niveau des provinces endémiques, les tendances sont différentes ces dix dernières années. Dans certaines provinces comme le Kasai occidentale la tendance est à la hausse ces trois dernières années. C'est aussi dans cette province qu'on rencontre un nombre élevé de NC au premier stade de la maladie, 42 % (n=30, N=71). La transmission pourrait être très active.

Par contre dans la province de la Tshopo (Isangi), le nombre des cas semble être stationnaire autour de 25 NC par an ces trois dernières années. Dans cette province, 92% de NC diagnostiqués en 2023 sont au premier stade de la maladie.

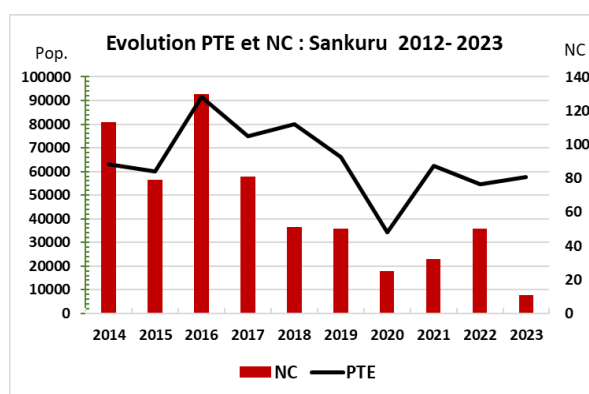
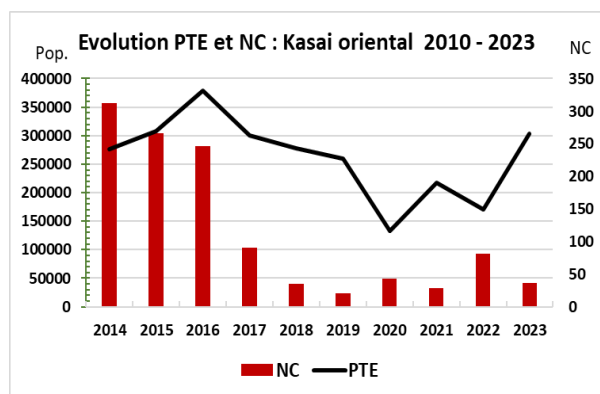


Fig. 16 : Evolution de la PTE et NC au Kasai oriental entre 2014 et 2023 et **Fig 17** : Evolution de la PTE et NC au Sankuru entre 2014 et 2023.

Dans les coordinations provinciales du Sankuru et du Kasai oriental (province du Kasai oriental et Lomami), les cas augmentent entre 2020 et 2022 avec une baisse en 2023. La population totale examinée a augmenté surtout au Kasai oriental. Dans ces deux coordinations, on a amélioré la couverture en surveillance passive en intégrant le dépistage /diagnostic et traitement dans les HGR et CS dans les zones de santé.

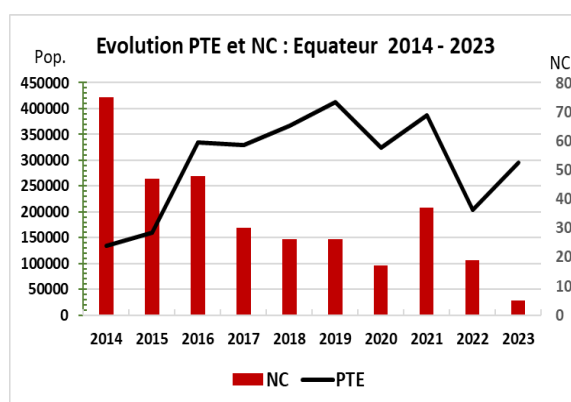
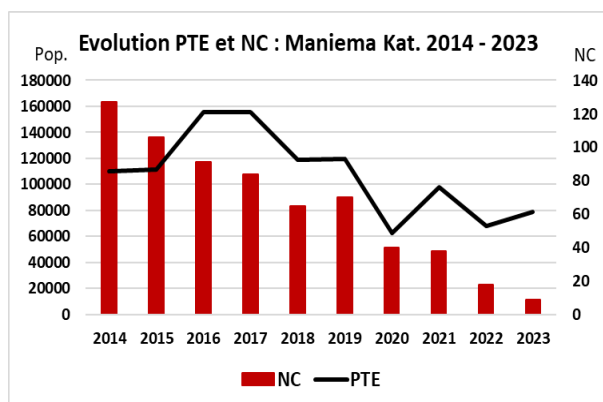


Fig. 18 : Evolution de la PTE et NC au Maniema Katanga entre 2014 et 2023 et **Fig 19** : Evolution de la PTE et NC à L'Equateur entre 2014 et 2023.

Dans d'autres provinces par contre la tendance est à la baisse ces trois dernières années comme dans le Maniema Katanga, le grand Equateur et à Kinshasa.

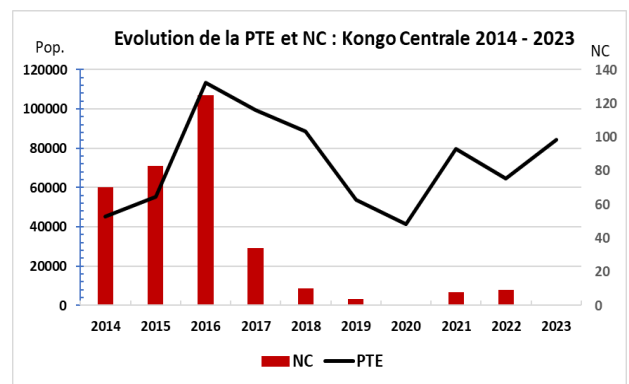
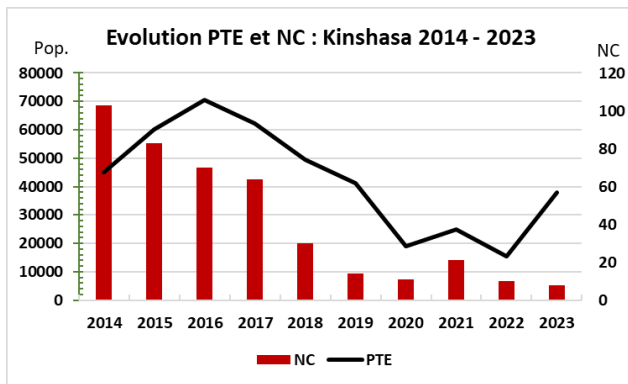


Fig. 20 : Evolution de la PTE et NC à Kinshasa entre 2014 et 2023 et Fig 21 : Evolution de la PTE et NC au Kongo Central entre 2014 et 2023.

Dans la province du Kongo central, les cas commencent à devenir de plus en plus rares. Il y a même des années avec zéro cas comme en 2020 et 2023. On rencontre cette rareté de cas aussi dans la coordination de l'Equateur sud (province de l'Equateur et de la Tshuapa). Dans ces deux parties du pays on a besoin d'une bonne surveillance en passif.

4. Contrôle du vecteur

4.1. Approche verticale

Tableau 16 : les zones d'évaluation entomologique et déploiement des mini-écrans pour le contrôle du vecteur en approche verticale en 2023

CPLTHA	Activités	Nombre	Zone de santé	Résultats
Bandundu sud	Evaluations entomologique.	2	Bulungu, Mokala,Kimputu	14231 écrans déployés, 232 pièges placés dans 29 sites, 48 mouches capturées (densité apparentée de 0 ,0025%.)
	Déploiement des mini écrans.	2	Bonga et Masi Manimba	35700 écrans déployés, 602 pièges placés dans 75 sites,153 mouches capturées (densité apparentée de 0,0008 %.)
Bandundu Nord	Evaluation entomologique	2	Bandundu, Bagata, Bokoro, Sia et Djuma	12123 mini écrans déployés, 224 pièges places dans 55 sites (densité apparente et de 0,0038 %.)
	Déploiement des mini écrans.	2		
Total				62054 mini écrans déployés et 1058 pièges placés

L'activité planifiée dans 12 zone de santé n'a été menée que dans 10 zones de santé, à cause de l'insécurité dans deux zone de santé (Bolobo et Kwamouth) au lieu de 12. Plus de 60 000 mini écrans et plus de 1000 pièges ont été déployés dans ces zones de sante sous intervention avec une diminution d'environ 80% de la densité des glossines .

Suivis entomologiques et déploiement de mii-écrans dans les provinces du Kwilu et MaiNdombe en 2023 (LAV verticale)

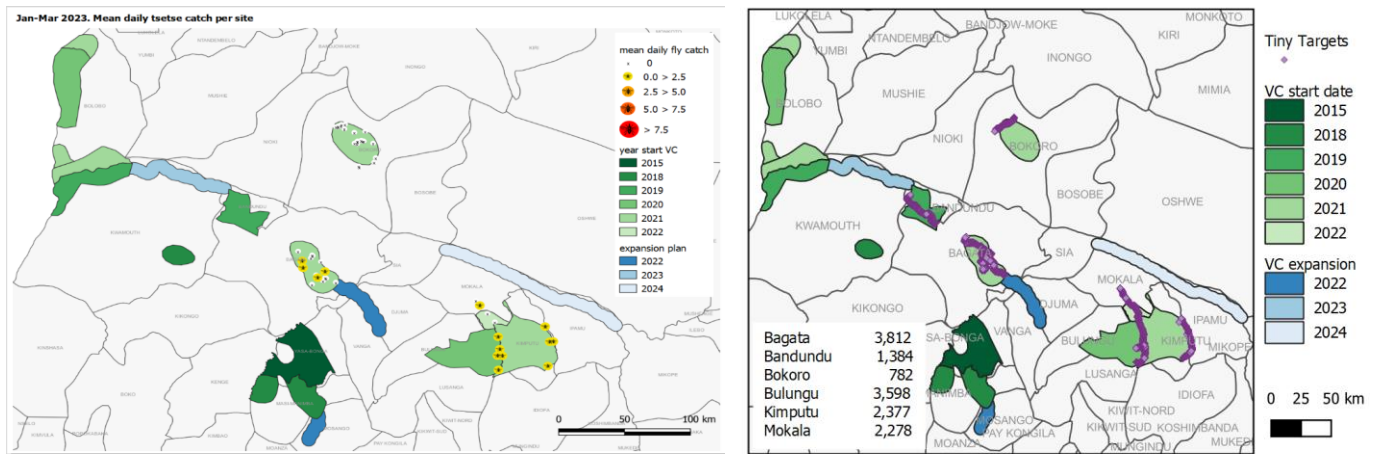


Fig.22 : Suivis entomologiques dans les ZS de Bulungu, Mokala, Kimputu, Masi Manimba et Yasa Bonga et **Fig.23** : Déploiement de 14231 mini-ecrans dans les ZS de Bagata, Bandundu, Bokoro, Mokala



Fig.24 : image de placement des mini-écrans et piège le long d'une rivière dans la province du Kwilu

4.2. Approche communautaire (horizontale)

Tableau 17 : les zones de déploiement des mini-écrans et sensibilisation pour le contrôle du vecteur avec l'approche communautaire en 2023

CPLTHA	Activités	Zone de santé	Nbre Village	Résultats
Bandundu Nord	déploiements des mini-écrans	Bandundu et Kikongo	31 villages	1 ^{er} passage: 253 Recos utilisés, 12.655 ménages sensibilisés, 155 pièges placés - 87 mouches capturées et 4.650 mini-écrans placés
Bandundu Sud		Kimputu et Bulungu	53 villages	2 ^{eme} passage: 64 mouches capturées, 4800 mini-écrans placés 1 ^{er} passage: 313 Recos utilisés ,265 pièges placés, 115 mouches récoltées ,7950 mini-écrans placés , 2 ^{eme} passage: 81 mouches récoltées
		Masimanimba, Yasa bonga	91 villages	198 Recos, 4950 mini écrans déployés, 53 mouches capturées
Bandundu Nord	sensibilisation Communautaire	Nioki, Mushie	21 villages	sensibilisation réalisée
		Kwamouth		non réalisée à cause de l'insécurité.

Les courbes évolutives de six déploiements des mini-écrans dans les zones de santé de Bandundu et de Kikongo en 2023

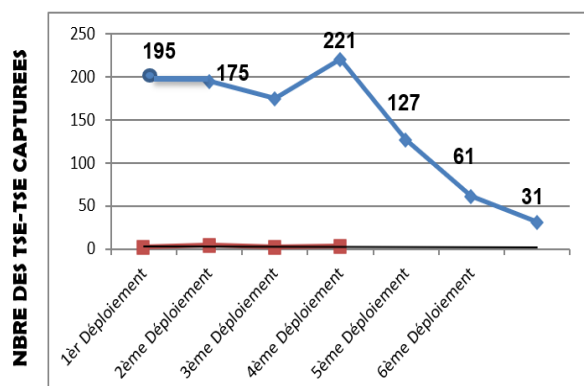


Fig 25 : Déploiement dans la ZS Bandundu

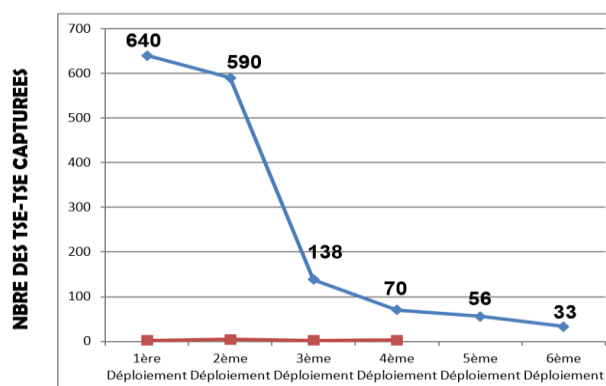


Fig.26 : Déploiement dans la ZS de KIKONGO



Fig 27 : Image de placement des mini-écrans dans les sites de contact homme-mouche dans la province du Kwilu **avec** l'approche communautaire.

5. Activités d'appui

5.1. Outils TrypElim de collecte des données

Tableau 18 : Suivi de la synchronisation des tablettes des UM et MUM dans les coordinations provinciales en 2023

N°	Coordinations THA	Capacité de synchroniser	Synchronisation 2023 - Complétude			Reprogrammation du DA avec l'outil Trypelim en 2023
			Prévu	Réalisée	%	
1	Bandundu Nord	Oui	264	264	100,0	Oui
2	Bandundu Sud	Oui	240	240	100,0	Oui
3	Kasaï Oriental	Oui	120	119	99,2	Oui
4	Kasaï Occidental	Oui	96	95	99,0	Non
5	Equateur Nord	Oui	72	72	100,0	Non
6	Equateur Sud	Oui	48	46	95,8	Non
7	Kinshasa	Oui	24	24	100,0	Non
8	Kongo central	Oui	24	24	100,0	Non
9	Maniema/Kat.	Oui	48	48	100,0	Non
10	Tshopo	Oui	24	24	100,0	Non
11	Sankuru	Oui	48	48	100,0	Non
Total			1008	1004	99,6	

Actuellement, il n'y a que trois coordinations provinciales qui peuvent faire la reprogrammation du DA avec le support de l'outil TrypElim. Pour permettre aux autres coordinations provinciales d'être en mesure d'utiliser le support de l'outil TrypElim il faut encore compléter les Shape files des aires de santé.

Dashboard :

Plusieurs améliorations sont faites ces trois dernières années (2021-2023) dans la qualité des données, la synchronisation des données et la stabilisation de l'outil Dashboard :

L'amélioration du module « rapport » qui consiste à générer le tableau de surveillance épidémiologique permettant de voir les villages visités en DA ainsi que la population examinée, les tests effectués, les résultats puis les stades de la maladie pour les cas. Les données de DP y sont également rapportées pour les coordinations ayant des structures digitalisées.

L'amélioration du module « reprogrammation » : en donnant la possibilité de découper les limites des Aire de santé, mais aussi l'amélioration de son module de macro planification en donnant la possibilité d'équilibrer les populations des AS endémiques en fonction de la capacité des Unités mobiles.

L'amélioration de la qualité des données, précisément celle de la complétude (de plus de 95%) des cas diagnostiqués les sept dernières années (2017-2023) et leurs localisations.

Un système de notifications automatique sous forme de mail a été mise en place. Ces notifications sont envoyées automatiquement aux coordonnateurs dès qu'un résultat de diagnostic positif est synchronisé pour leur permettre de suivre.

L'appropriation de l'outil Dashboard reste encore faible à ce jour, seule quatre coordinations provinciales peuvent travailler quotidiennement dans le nettoyage, la saisie et l'analyse des données en collaboration avec l'équipe digitale du niveau central. La connexion Internet reste encore un défi pour certaines coordinations comme Sankuru, Maniema/Katanga et Equateur Sud. A ce jour le support papier reste encore nécessaire.

5.2. Formation des prestataires

Tableau 19 : Formation et recyclage des prestataires impliqués dans la lutte contre la THA

N ⁰	Structures	Catégorie	Nombre	Thématiques
1	Coord. Provinciale	MCP et logisticiens CPLTHA	Tous	Formation sur la gestion des Trypanocides et autres intrants
	Coord. Nationale	Membre division logistique		
2	14 Zone de sante dans la coord. Kasai oriental	Médecins	102	Renforcement des capacités de dépistage et diagnostic de la THA
		Infirmiers	75	
		Techniciens de labo	41	
	8 Zones de sante dans la coord. Du Sankuru	Médecins	23	
		Infirmiers	24	
3	Coord. : EQN, MNK, KC, KOCC, KIN et	Microscopistes UM	Tous	Recyclage des techniciens de labo des UM et MUM dans le diagnostic et assurance qualité
		Chef UM		
	Coord. BDDS, EQN et KOCC	Microscopiste MUM		

5.3. Recherche

Tableau 20 : les études épidémiologiques et cliniques réalisées en collaboration avec le PNLTHA en 2023

N ⁰	Titre	Description	Lieu	Etat d'avancement
1	STROGHAT	Évaluer si une stratégie basée sur un traitement élargie aux sujets avec examen parasitologique négatif et séropositifs pour gHAT avec acoziborole peut amener à l'interruption de la transmission de T.b. gambiense dans un foyer continental.	Coord. Equateur Nord	En préparation : démarrage en mars 2024)
		Evaluer la sécurité de l'acoziborole dans des sujets gHAT séropositifs avec examen parasitologique négatif.		
2	Etude Anthropologique	Perception et Acceptabilité du traitement oral des suspect sérologique THA	Coord. Equateur Nord	Etude terminée
3	DNDi-OXA-04-HAT (Séropositifs)	Etude évaluant la sécurité d'Acoziborole chez les sujets séropositifs à g-HAT et non confirmés par diagnostic parasitologique : une étude multicentrique, en double aveugle, randomisée et contrôlée versus placebo	Coord. BDDN, BDDS et Kasaï OR	Fin des inclusions / analyse des données
4	DNDi-OXA-05-HAT (Pédiatriques)	Étude multicentrique en ouvert évaluant la pharmacocinétique, l'efficacité, la sécurité d'emploi et la tolérance d'une dose unique d'Acoziborole à jeun chez les patients pédiatriques âgés de 1 à 14 ans atteints de la trypanosomiose humaine africaine à T.b. gambiense	Coord. BDDN, BDDS et Kasaï OR	Fin des inclusions / analyse des données
5	Projet HAT Plus : Passive screening intégration_	Intégrer le dépistage/diagnostic et le traitement de la THA dans les structures sanitaires du premier et deuxième échelon du système de santé et faire un transfert progressif des capacités techniques et administratives au niveau intermédiaire.	Coord. Kasaï OR et Sankuru	Phase pilote terminée

5.4. Suivi des activités

Tableau 21: La moyenne mensuelle des jours d'itinérance et de dépistage par les UM

N ^o	Coordination THA	Nbre UM	Total Mois Itinérances réalisées	Total Jours- Itinérances réalisées	Total Jours dépistage actif	Moyenne des jours dépistage par mois par UM
1	Bandundu Nord	6	72	1402	1315	18
2	Bandundu Sud	6	71	1412	1341	19
3	Equateur Nord	3	33	730	652	20
4	Equateur Sud	0	0	0	0	0
5	Kasai occidental	3	34	567	531	16
6	Kasai Oriental	4	48	946	889	19
7	Sankuru	1	10	194	152	15
8	Maniema Kat.	2	21	404	308	15
9	Kongo central	0	0	0	0	0
10	Kinshasa	1	11		209	19
11	Tshopo	1	12	242	230	19
Total		27	312	5897	5627	18

Tableau 22 : La moyenne mensuelle des jours d'itinérance et de dépistage par les MUM

N ^o	Coordination THA	Nbre MUM	Total Mois Itinérances réalisées	Total Jours- Itinérances réalisées	Total Jours dépistage actif	Moyenne des jours dépistage par mois par MUM
1	Bandundu Nord	5	58	1077	998	17
2	Bandundu Sud	6	67	1341	1274	19
3	Equateur Nord	1	11	225	218	20
4	Equateur Sud	2	16	288	232	15
5	Kasai occidental	1	12	196	179	15
6	Kasai Oriental	1	12	236	224	19
7	Sankuru	1	11	223	191	17
8	Maniema Kat.	0	0	0	0	0
9	Kongo central	1	11	205	186	17
10	Kinshasa	0	0	0	0	0
11	Tshopo	0	0	0	0	0
Total		18	198	3791	3502	18

Tableau 23 : Supervision des UM et MUM par les coordinations provinciales en 2023

N ^o	Coordination THA	Nbre Prévue	Nbre réalisées	%
1	Bandundu Nord	44	41	93,2
2	Bandundu Sud	60	58	96,7
3	Equateur Nord	232	130	56,0
4	Equateur Sud	56	56	100,0
5	Kasai occidental	38	36	94,7
6	Kasai Oriental	20	11	55,0
7	Sankuru	8	5	62,5
8	Maniema Katanga	8	7	87,5
9	Kongo central	4	6	150,0
10	Kinshasa	4	3	75,0
11	Tshopo	8	8	100,0
Total		482	361	74,9

La coordination nationale supervise chaque coordination provinciale au moins deux fois par an. En 2023. Plusieurs missions de supervisions et de validation des données avec des UM et les coordinations provinciales ont été réalisées.

Tableau 24 : Rapportage des activités de lutte contre la THA par le niveau intermédiaire et périphérique en 2023

N°	Coordination THA	Rapport mensuel des UM			Rapport trimestriel des coord.		
		Nbre attendu	Promptitude	Complétude (%)	Nbre attendu	Promptitude	Complétude (%)
1	Bandundu Nord	72	72	100%	4	4	100%
2	Bandundu Sud	140	125	100%	4	4	100%
3	Equateur Nord	48	48	100%	4	3	100%
4	Equateur Sud	12	0	100%	4	3	100%
5	Kasai occidental	48	48	100%	4	4	100%
6	Kasai Oriental	48	48	100%	4	4	100%
7	Sankuru	12	0	100%	4	4	100%
8	Maniema Katanga	24	0	100%	4	3	100%
9	Kongo central	12	12	100%	4	4	100%
10	Kinshasa	12	12	100%	4	4	100%
11	Tshopo	12	12	100%	4	4	100%
Total		440	377		44	41	

La coordination nationale rapporte chaque trimestre au secrétariat général de la santé. En 2023 tous les 4 rapports prévus ont été produits.

6. Conclusion

Les cas ont beaucoup diminué (394 NC) en 2023 comparé à 2022 où l'on a notifié 516 NC en RDC. Le taux d'infection en DA est de 1 pour 10 000 personnes. Les tendances évolutives de nombre des cas sont différentes selon les Coordinations de lutte contre THA. On trouve des coordinations où la tendance est à la hausse ces trois dernières années, des coordinations où la tendance est à la baisse et celles où la variation est en dents de scie. Les interventions doivent être adaptées selon les spécificités de chaque coordination de lutte contre la THA. Il y a trois provinces, la province du Kongo Central couverte par la coordination de Kinshasa Kongo central et les provinces de l'Equateur et de la Tshuapa couvertes par la coordination de l'Equateur sud dont les cas ont diminué énormément (certaines années on a zéro cas). Ces deux coordinations provinciales ont besoin d'une bonne surveillance en passif et envisager la documentation de l'élimination de la THA dans ces parties de la RDC. Il y a aussi deux coordinations provinciales (Bandundu sud et Kasai occidental) où le taux d'infection est élevé, on a besoin de renforcer les interventions. Et enfin les coordinations provinciales avec un nombre élevé des malades au stade précoce (Kasai occidental et Tshopo) ont besoin d'y associer le contrôle du vecteur.

Il y a plusieurs défis pour l'année 2024, mais l'amélioration de la couverture de la population à risque en surveillance passive dans les provinces endémiques reste une intervention prioritaire.

7. Références

- Franco JR, Cecchi G, Paone M, Diarra A, Grout L, Kadima Ebeja A, et al. (2022) The elimination of human African trypanosomiasis: Achievements in relation to WHO road map targets for 2020. *PLoS Negl Trop Dis* 16(1)
- Franco JR, Cecchi G, Priotto G, Paone M, Diarra A, Grout L, et al. (2018) Monitoring the elimination of human African trypanosomiasis: Update to 2016. *PLoS Negl Trop Dis* 12(12)
- WHO (2012) Accelerating work to overcome the global impact of neglected tropical disease: A roadmap for implementation, roadmap approved by the strategic advisory group for neglected tropical diseases in 2011, Geneva
- Ministère du Plan et Macro International. Enquête Démographique et de Santé, République Démocratique du Congo 2007. Calverton, Maryland, U.S.A: Ministère du Plan et Macro International. 2008.
- Ministère de la Santé Publique (MSP) en République Démocratique du Congo (2006) Stratégie de Renforcement du Système de Santé <http://www.minisanterdc.cd>
- Ministère du Plan et Suivi de la Mise en œuvre de la Révolution de la Modernité (MPSMRM), Ministère de la Santé Publique (MSP) et ICF International, 2014. Enquête Démographique et de Santé en République Démocratique du Congo 2013-2014. Rockville, Maryland, USA: MPSMRM, MSP et ICF International.
- Programme National de lutte contre la THA (2017). Rapport annuel 2016. Kinshasa.
- Programme National de lutte contre la THA (2015). Rapport annuel 2014. Kinshasa.
- Holmes P (2014) First WHO Meeting of Stakeholders on Elimination of Gambiense Human African Trypanosomiasis. *PLoS Negl Trop Dis* 8(10): e3244
- World Health Organization (2020) Ending the neglect to attain the sustainable development goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Geneva